

Fecha Última Actualización: 09-02-2022 14:04:18

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Víctor Segundo Alvear Garrido
Edad : 68a 2m 20d
Dirección : Nuevo Amanecer 4179

Rut : 7.373.276-K
Fecha Nacto: 20/11/1953
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1718440
Sexo : Masculino
Teléfono : 97 8812 048

N° Epicrisis
294503

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 20/01/2022 16:48

Días Estadía: 20

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 09/02/2022 14:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Tos con expectoración

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR: 20/01/22
FI UPC: 20/01/22
FI UTIM: 29/01/22
FI Sala: 02/02/2022

ANTECEDENTES

- Mórbidos: dudoso antecedente de EPOC, tabaquismo importante suspendido (no se cuenta con IPA), hipoacusia
- Medicamentos: Broncodilatador
- Alergias: familiares niegan
- Quirúrgicos: Hernia inguinal operada, Absceso anal operado
- Hábitos: Tabaquismo suspendido, OH (-), drogas (-)
- Inmunizaciones: 3 dosis COVID 19
- Hospitalizaciones recientes: (-)

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, ingresa el 20/01/2021 a las 14:00 hrs por cuadro de una semana de evolución caracterizado por tos húmeda y productiva con expectoración purulenta que se exacerba las 24 horas previas. A su ingreso al servicio de urgencias se presenta normotenso, taquicárdico (126 latidos por minuto), febril (38.7°C), SatO2 88% ambiental, con sibilancias espiratorias a la auscultación pulmonar, al laboratorio destaca: PCR 156, K 3.33, venosos: pH 7.422 PO2 51 PCO2 33, bicarbonato 22, leucocitos 8470, plaquetas 98000, TTPA 45. PCR COVID (-). RxTx con focos de condensación bibasales. En SUA evoluciona con apremio respiratorio, requiere VMNI sin respuesta, luego CNAF sin respuesta, por lo que se intuba en servicio de urgencia. Se solicita AngioTC de tórax que informa examen sin signos de tromboembolismo pulmonar hasta nivel segmentario, extenso foco de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo, asociado a opacidades nodulares con áreas de cavitación central y signos de bronquiolititis celular pulmonares bilaterales, hallazgos de probable etiología infecciosa, sugieren considerar en diagnóstico diferencial infección por micobacterias (con diseminación endobronquial), leve enfisema centroacinar y paraseptal pulmonar bilateral, cambios morfológicos de daño hepático crónico. Ingresa a UCI para diagnóstico, monitorización y tratamiento.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

Fecha Epicrisis : 09/02/2022 14:04

Página 1 de 3

1. Neumonía grave adquirida en la comunidad
2. Falla respiratoria mixta hipercápnica e hipoxémica ¿ IOT 20/01/2021
3. Falla renal aguda KDIGO 2
4. Coagulopatía
5. Plaquetopenia
6. Acidosis metabólica hiperlactacidémica

EVOLUCIÓN POR PLANES:

1. Hemodinámico: Ingresó con lactato elevado que barre tras aporte de cristaloides, se apoyó con NAD dosis bajas en relación a sedación. Sin sangrados, sin arritmias. En UTIM estable, hemodinamia autosostenida, bien perfundido, sin conflicto. Se mantiene monitoreo no invasivo

2. Respiratorio: Ingresó con insuficiencia respiratoria aguda parcial por NAC cavitada ATS IV que ameritó curso de VMI desde 20/01 al 28/01. Paciente con enfisema y hábito tabáquico pesado (suspendido), probablemente con una LCFA de base que deberá estudiarse en ambulatorio.

En cuanto a su NAC cavitada, primer TC 22/01 informa extenso foco condensante en LII con componente cavitado, sugerente de micobacterias, GenXpert de expectoración (-) del ingreso y control de TC evolutivo del 25/01 y 07/2 informa resolución casi total del componente cavitado, sin imágenes que sugieran infección por mycobacterias.

Ante lo anterior, mejoría sustancial clínica-imagenológica, y discutido con broncopulmonar, se decide no LBA, mantener ATB prolongada acorde controles imagenológicos, control con especialidad con TC de torax y pruebas de función pulmonar.

3. Infeccioso: Neumonía cavitada, según lo antes descrito, del estudio:

- PCR GenXpert 20/1: negativa, cultivo Koch (P), sin BK.

- HC 21/1: ambos (+) S. hominis MR

- CAET 23/1: negativo

- HC 28/1: HC1 (-), HC2 (+) E. faecium MS + S. epidermidis MR.

- Serología HIV (-), VHB y VHC (-).

Inicialmente recibe ampicilina sulbactam (7), se añade Vancomicina (10) por bacteriemia por S. hominis MR.

Evoluciona con buena respuesta clínica, analítica e imagenológica.

Ya descrito, se decide por la respuesta en globo, no ahondar estudio con LBA.

En cuanto a bacteriemias por cocos gram positivos, se controló HC 04/2 negativo, sin bacteriemia persistente y se descarta razonablemente foco endomiocárdico con ecocardiograma TT del 09/2.

Indicación de ATB prolongada (6-8 semanas) acorde mejoría imagenológica, a definir por equipo de broncopulmonar.

4. Renal: Ingresó con AKI que mejora rápidamente con volemicización.

5. Gastroenterología: Se pesquisa en imagen de ingreso, signos compatibles con DHC, clínica acompaña.

Se solicitó estudio etiológico, VHB, VHC, HIV (-), HbA1c% 5.0, IgG 2173 con ANA 1:160, AMA y ASMA (-).

Eco abdominal 07/02: Cambios morfológicos de daño hepático crónico, sin marcadores de hipertensión portal.

En suma, impresiona un DHC Child-A con sospecha de HAI, queda en control ambulatorio co especialidad.

DIAGNOSTICOS DE EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda parcial resuelta

- NAC cavitada de lóbulo inferior izquierdo ¿ ATS IV

- Obs componente de LCFA exacerbada

- VMI 20/01 al 28/01

- Sin etiología aislada.

2. Bacteriemia por S. hominis MR y E. faecalis MS, tratadas, EBSA desestimada.

3. DHC debut, en estudio, sospecha HAI.

4. Antecedentes: tabaquismo suspendido (IPA 200, 3-4 caj/d por 50 años), Obs LCFA, hipoacusia leve.

Inta. Carrera / Dr. Avaria

Diagnóstico de Egreso

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA - 1. Insuficiencia Respiratoria Aguda parcial resuelta

1.1. NAC cavitada de lóbulo inferior izquierdo ¿ ATS IV

Fecha Epicrisis : 09/02/2022 14:04

Fecha Última Actualización: 09-02-2022 14:04:18

Página 3 de 3

- 1.2.Obs componente de LCFA exacerbada
- 1.3.VMI 20/01 al 28/01
- 1.4.Sin etiología aislada, sospecha Mycobacterias
- 2.Bacteriemia por S. hominis MR y E. faecalis MS, tratadas de foco en estudio.
- 3.DHC debut, en estudio, sospecha HAI.
- 4.Antecedentes: tabaquismo suspendido (IPA 200, 3-4 caj/d por 50 años), Obs LCFA, hipoacusia leve.

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Actualmente, paciente en buenas condiciones generales, normocardico, normotenso y afebril, sin requerimientos de O2, con buena mecánica. Actualmente completando tratamiento antibiotico con AmociClav, en su 7° día de tratamiento.

Plan Post Alta

1. Medicamentos:
 - Amoxicilina/Ac. Clavulanico 500/125mg cada 8 horas por vía horal, hasta indicación por equipo de Broncopulmonar
 - Bromuro de Ipratropio 2 puffs cada 6 horas por AEC
2. Controles:
 - Control con Gastroenterología ambulatorio en CDT CASR, se solicita por sistema.
 - Control con Broncopulmonar ambulatorio en CDT CASR, se solicita por sistema.
 - > Coordinar toma de TC de tórax previo a control con Broncopulmonar (se adjunta orden de examen).
3. Acudir a servicio de urgencias SOS si fiebre, tos con expectoración, dificultad respiratoria, o bien, de estimarlo necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Sin Indicación De Reposo En Cama, Seguir Con Ejercicios De Knt Motora, Levantar Diariamente.

Régimen Alimentario : Blando

Medicamentos :

Controles

Josefina Ignacia Carrera Schisano
INTERNO

Bec. Maria Olga Victoria Rios Lyon
Becado/Residente

Nicolas Avaria Navarro
Médico Tratante (Staff)